Histórico Clínico do Paciente: Carlos Almeida

PACIENTE FICTÍCIO: dados inventados para teste de um sistema de busca. Não corresponde a nenhuma pessoa real.

Identificação

- Nome: Carlos Almeida
- ID no sistema: 104
- Data de nascimento: 20/05/1977 (49 anos)
- Sexo: masculino
- Telefone: (31) 90000-0104
- Atendimento: particular

Alergias e reações adversas

- **ALERGIA A PENICILINAS:** urticária generalizada e inchaço dos lábios depois de tomar amoxicilina, em 2019. Não usar amoxicilina nem outras penicilinas.
- Tolerou dipirona e paracetamol sem reação.
- Anestésico: usou lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 em 2022 e em 2026, sem intercorrência.
- Sem alergia a látex.

Condições de saúde

- Hipertensão arterial controlada. Pressão habitual de 128/82 mmHg. Última aferição no consultório: 134/86 mmHg, em 05/11/2026.
- Tabagista: cerca de 10 cigarros por dia, há 20 anos.
- Sem diabetes, sem doença valvar cardíaca, sem histórico de endocardite e sem uso de anticoagulantes.

Medicamentos em uso

- Losartana potássica 50 mg, um comprimido pela manhã.
- Sinvastatina 20 mg, um comprimido à noite.
- Observação: anti-inflamatórios podem reduzir o efeito da losartana e sobrecarregar os rins; evitar quando possível.

Histórico odontológico e tratamentos anteriores

- 03/2018: restaurações em resina composta nos dentes 36 e 46.
- 08/2020: tratamento endodôntico (canal) do dente 26, concluído. Coroa metalocerâmica instalada em 2021.
- 05/2022: extração do dente 48 (siso incluso), sem intercorrências e com cicatrização normal.
- 02/2023 e 02/2024: limpeza e raspagem supragengival, com retornos irregulares.
- 09/2024: restauração oclusal em resina no dente 16.

Última consulta: 05/11/2026 (quinta-feira)

Queixa: dor espontânea no dente 46 havia 3 dias, que piora ao deitar, acorda o paciente à noite e dura bastante depois de tomar algo gelado.

Exame: pressão arterial 134/86 mmHg, sem febre e sem inchaço no rosto. Cárie profunda sob restauração antiga infiltrada no dente 46. Teste ao frio com resposta intensa e prolongada. Percussão vertical levemente dolorosa. Radiografia periapical: cárie profunda próxima à câmara pulpar, sem lesão evidente na ponta da raiz.

Diagnóstico: pulpite irreversível sintomática do dente 46.

Conduta realizada: anestesia com lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000, 1 tubete. Pulpectomia de urgência, irrigação com hipoclorito de sódio 2,5%, medicação intracanal com hidróxido de cálcio e selamento provisório. O paciente tolerou bem.

Prescrição: paracetamol 750 mg a cada 8 horas por 3 dias, se houver dor. Ibuprofeno e outros anti-inflamatórios foram evitados por causa da hipertensão e do uso de losartana. Antibiótico não foi indicado, pois não havia sinais de infecção, e amoxicilina é contraindicada pela alergia à penicilina.

Orientações: evitar mastigar do lado direito inferior. Procurar a clínica em caso de febre ou inchaço.

Retorno: recomendado em até 7 dias (até 12/11/2026) para limpeza e obturação dos canais do dente 46. A consulta de retorno ainda não foi agendada.

Observações do paciente

- Ansiedade leve durante procedimentos.
- Prefere horários pela manhã.

Pendências e cuidados

- Concluir o tratamento de canal do dente 46 e restaurá-lo definitivamente.
- Orientar sobre parar de fumar.
- Reavaliar a gengiva (avaliação periodontal) na próxima consulta de rotina.